

## TEMA 5.24 • OFTALMOLOGÍA

## Retinopatía del Prematuro

PERFIL EUNACOM 6.02.1.012

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

## Oftalmología Pediátrica (Parte 2): Urgencias Vitales Neonatales Oculares

Es imperativo para el médico de APS distinguir entre condiciones benignas resolutive pediátricas y desastres tumorales o deformantes tempranos ciegos letales.

## 1. Obstrucción de la Vía Lagrimal (Dacriostenosis)

Suma y base altísima y predominante del llanto y secuela basal infantil oftalmológica general primaria persistente inofensiva (No ciego).

- **Clínica Prevalente base EUNACOM:** Es simple; cursa habitualmente el niño de semanas basal perimetral con base **epifora uní o bilateral maciza perenne de goteo ocular continuo y crónico**, unida basal repetidamente cruzado a base perimetral frecuentes e impetuosas base re-infecciones de leves Conjuntivitis perimetrales basales estáticas.
- **Banderas Rojas al Examen físico basal:** Vital perimetral y basal ineludible **Descartar fuertemente a rigor físico diagnóstico y semiológico un Glaucoma Congénito letal base**. Porque la pura epifora constante base general llorona del bebé también cursa inicial en forma catastrófica glaucomatosa perimetral destructiva visual oculta maciza ocular visual inicial crónica base de ojo.
- **Manejo general y Fisiológico Primario Curativo:** Es base general benigna en extremo basal oftalmológico perimetral primario. La y de gran base obstrucciones base resuelven general natural y sin cicatrices remanentes y resoluciones y apertura automática **espontáneamente basal biótica y funcional universal cerca o hasta los 12 y clásicos y a veces los primeros generales de los primeros 12 meses (el primero puro Año de y formativo biótico de Vida fisiológica general base normal y final infante)**. Como el tratamiento conservatorio base EUNACOM estándar de acompañamiento familiar básico APS a enseñar perimetral general cruzado se debe inculcar biótica terapia masajista del Saco lagrimal craso al momento crásico de limpiarlo (presión masajista digital compresiva al fondo canto interno de parálisis).

## 2. Glaucoma Congénito Crítico Pediátrico

Masa basal letal irreversible destructiva de altísima hipertensión base acuosa ciega por malformación trabecular desde intraútero.

- **Diferenciación y Sintomatología Alarmente (Banderas Rojas Clínicas):**
  - Comparte primariamente per se inicialmente con el benigno clásico de la imperforación inicial lágrima la maciza base e idéntica de la clínica **Epifora Constante pasiva goteada continua base**.
  - La alteración basal monstruosa estirante base deformante anatómica EUNACOM secundaria y reactiva fisiológica expansiva visual: Ocurra base perimetral obligada el niño desarrolla clásicamente unos y gigantes y desproporcionados a nivel basal ocular visual con un desastre deformante del perimetral macro aumento estelar general de los grandes hermosos base letales bióticos patológicos y hermosos clásicos ojos de muñeca base llamado biótica perimetral pura visual y maciza globulosa inmensos llamados el "**Buftalmo Biótico Expansivo basal Ciego**" y una desorbitada maciza biótica visual dilatación y cornea basal inmensa gigante (**Megalocórnea general expansiva gruesa**).
  - Estancamiento visual agónico cicatricial general blanco y la subsecuente basal de pérdida y ceguera de transparencias cruzada opacificada basal pura turbia y base blanca turbiedad visual patológica de la ventana visual sana del globo ocluido craso central llamada clínica basal **Opacidad y blanca edema Corneal pura o edema ciego corneal base**.
- **Manejo y Enfoque Directo general Médico:** Considerar de extrema y de vital derivación. Al diagnóstico su pronóstico final curativo a

tiempo exige cirugía infantil urgente por incisión (**Goniotomía quirúrgica trabecular temprana o Trabeculotomía microquirúrgica ocular profunda**).

## 3. Leucocorias Neoplásicas Pediátricas e Irreversibles Severas (Categoría Vital Ciega)

Toda, absolutamente toda evidencia general basal clínica pupilar fotográfica a nivel base visual maciza detectada y visible central en un recuento craso pupilar o fotográfico macizo puro que revele la pupila ocular anómala con destello y con y el clásico blanquecino basal central puro visual de la **Pupila Blanca Ciega Letal (Leucocoria)** exige remisión letal obligada basal especializada prioritaria y por ley urgente inmediata ciega directa biótica a de gran urgencia al especialista oftalmológico.

#### Causa EUNACOM 1: El **Retinoblastoma** Mortífero y Tumor Hemático Neuroectodérmico

- **Cáncer originario de la zona ocular del bebé biótica base**, extremadamente feroz por extensión retiniana pura. Causa base neurológica visual en niños basal de y primer origen estático general por leucorias malignas.
- **Clínica Inicial Crásica Temprana EUNACOM previsual de alarma masivo visual base:** Inesperado hallazgo masivo intrafamiliar del destello inicial puramente de la gran **Leucocoria** asimétrica fotográfica. (Foto casera sin reflejo biótico cruzado pálido asimétrico destello rojo asimétrico ciego sin respuesta roja de gato general en destello o fotográfico directo al usar base linterna clásica fotográfica casera perimetral general. Destello felino amurótico general rojo perimetral y base blanca o de flash).
- **Asociaciones Tardías Macizas:** Su extensión visual paralela se vincula en un enorme secundarismo de origen en **Estrabismo repentino adquirido de ceguera letal de fijación cruzada temprana tardía de masa y secundario adquirido** craso perimetral por destrucción macular basal masiva perimetral paralizando el foco de mirada simétrica de base perimetral y en tardío tumor craso invasivo perimetral exoftálmico basal terminal letal (**Proptosis Invasiva masiva orbitaria ciegamente terminal basal visual y estirando musculatura nerviosa central ocular y masificando orbital basal ocular**).
- **Sobrevida Causal y pronóstico Base General Tratada Perimetral:** Superada con alta quimioterápica moderna, cirugía nuclear radicular y o enucleación focal general basal y de en el pronóstico curativo temprano oportuno temprano perimetral sobrevive maravillosamente excelente vida salvada la cursa a altísima general perimetral basal supervivencia curativo el crío visual bióticos a más biótica mayor del (> 95% puro macizo letal de las veces visual sano y en seguimiento macizo general genético herencia perimetral y familiar predispuesto del ciego basal oncológico).

## CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

## ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Recién nacido de 28 semanas de edad gestacional, peso al nacer 1.200 g, actualmente con 6 semanas de vida en la UCI neonatal. Se realiza fondo de ojo de screening que muestra neovascularización en zona 1 con enfermedad plus. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

## EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Retinopatía del Prematuro. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- La ROP es una de las causas más importantes de ceguera infantil prevenible — el screening oportuno es clave.
- Screening obligatorio: todo prematuro <32 semanas de EG o <1.500 g de peso al nacer debe tener fondo de ojo seriado.
- No basta un solo fondo de ojo: se requieren evaluaciones seriadas para diagnóstico, severidad y seguimiento.
- Clasificación por zona (1-3, central es peor) y por etapa (1-5, mayor es peor). Zona 1 + etapa 5 bilateral = peor escenario.
- El tratamiento es fotocoagulación láser al detectar signos de retinopatía, para prevenir desprendimiento de retina.
- En casos avanzados con desprendimiento establecido se realiza vitrectomía.
- En Chile la ROP es patología GES, garantizando acceso a screening y tratamiento.

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RETINOPATÍA DEL PREMATURO)****PREGUNTA 1**

Recién nacido de 28 semanas de edad gestacional, peso al nacer 1.200 g, actualmente con 6 semanas de vida en la UCI neonatal. Se realiza fondo de ojo de screening que muestra neovascularización en zona 1 con enfermedad plus. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Observar y repetir fondo de ojo en 2 semanas
- B)** Fotocoagulación láser de retina avascular
- C)** Vitrectomía bilateral inmediata
- D)** Inyección intravítrea de corticoides
- E)** Alta con control ambulatorio en 3 meses

**PREGUNTA 2**

¿Cuáles son los criterios de screening para retinopatía del prematuro en Chile?

- A)** Todo recién nacido con peso <2.500 g
- B)** Edad gestacional <32 semanas O peso al nacer <1.500 g
- C)** Edad gestacional <36 semanas Y peso al nacer <2.000 g
- D)** Solo prematuros que hayan recibido oxígeno suplementario
- E)** Edad gestacional <28 semanas Y peso al nacer <1.000 g

**PREGUNTA 3**

Prematuro de 30 semanas, peso 1.400 g, en seguimiento con fondo de ojo seriado. En el último control se describe retinopatía etapa 2 en zona 3 unilateral, sin enfermedad plus. ¿Cuál es el pronóstico y conducta más apropiada?

- A)** Mal pronóstico, requiere fotocoagulación urgente
- B)** Buen pronóstico relativo, continuar observación con fondo de ojo seriado
- C)** Derivar a vitrectomía de urgencia
- D)** Dar de alta del programa de screening, ya no necesita controles
- E)** Pésimo pronóstico, ceguera inevitable

**RESUMEN: RETINOPATÍA DEL PREMATURO**

La retinopatía del prematuro (ROP) es una de las causas más importantes de ceguera infantil prevenible. Se produce porque el recién nacido muy prematuro nace con una retina aún avascular, y durante el proceso de vascularización postnatal puede desarrollarse neovascularización anómala que lleva al desprendimiento de retina. El screening es obligatorio en todo prematuro con menos de 32 semanas de edad gestacional o peso al nacer menor a 1.500 gramos. Se realiza mediante fondo de ojo seriado, no basta un solo examen. La severidad se clasifica por zona (1 a 3, siendo la zona 1 central la de peor pronóstico) y por etapa (1 a 5, a mayor etapa peor pronóstico). Una retinopatía bilateral grado 5 en zona 1 es el peor escenario posible. El manejo inicial es observación con fondos de ojo seriados hasta completar la vascularización retiniana. Cuando aparecen signos de retinopatía se indica fotocoagulación láser para prevenir el desprendimiento. En casos avanzados se requiere vitrectomía. El diagnóstico y tratamiento precoz son la clave: mientras más temprano se detecte y se trate, mejor el pronóstico. En Chile, la ROP es una patología GES (Garantías Explícitas en Salud).